Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Врач-оториноларинголог, специалист по хирургии головы и шеи

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

ФОРМА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Отопластика

Операция по коррекции оттопыренных ушей

Уважаемый пациент, эта форма составлена для того, чтобы **простым и понятным языком** рассказать вам о том, что необходимо знать о рекомендованной вам процедуре. Её цель — не напугать вас, а помочь вам принять решение **свободно и на основе достоверной информации**.

Пожалуйста, прочитайте эту форму не торопясь. Обо всём, что вам непонятно, спросите своего врача. Врач также устно объяснит вам риски, связанные именно с вашим состоянием. Давать или не давать согласие — исключительно ваше право.

СВЕДЕНИЯ О ПАЦИЕНТЕ И ПРОЦЕДУРЕ

Фамилия, имя: _____ Дата рождения: _____

№ паспорта / удостоверения личности: _____ № карты / протокола: _____

Телефон: _____ Дата информирования: _____

Планируемая дата процедуры: _____

Форма впервые передана пациенту (дата / эл. почта, WhatsApp, лично): _____

Врач, который выполняет процедуру и предоставляет информацию: **Op. Dr. Murat Ayata**

Больница / медицинское учреждение, где будет выполнена процедура: _____

Сторона: ☐ Правая ☐ Левая ☐ Обе

Вид анестезии: ☐ Общая анестезия ☐ Местная анестезия ☐ Местная анестезия + седация

Что будет корректироваться / ожидания пациента: _____

1 Ваше состояние и цель процедуры

Оттопыренные уши — это уши, которые отходят от головы под бóльшим углом, чем обычно, или у которых не сформировалась естественная складка ушного хряща (противозавиток). Это состояние обычно врождённое, не вредит здоровью и не влияет на слух. Однако, особенно в детском и подростковом возрасте, оно может приводить к насмешкам, потере уверенности в себе и социальной тревожности.

Цель отопластики — приблизить уши к голове так, чтобы они выглядели **естественно** и были как можно более **симметричными** с обеих сторон. Поскольку ушная раковина достигает бóльшей части своего взрослого размера примерно к 5–6 годам, операцию можно проводить **с 5–6 лет**; проведение её до школьного возраста может уберечь ребёнка от социальных трудностей. Если операция предстоит вашему ребёнку, важно учитывать его собственное желание и готовность.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Как выполняется процедура?

Операция проводится в операционной. Детям обычно проводят общую анестезию; взрослым — местную анестезию (при необходимости с седацией) или общую анестезию.

1. **Планирование и разметка:** Уши фотографируют, измеряют их расстояние от головы и размечают положение новой складки.
2. **Разрез:** Разрез кожи делают на **задней поверхности уха**, рядом с естественной складкой между ухом и головой. Поскольку этот рубец находится за ухом, он обычно не виден.
3. **Моделирование хряща:** На ушном хряще с помощью постоянных (нерассасывающихся) швов формируют новую складку (противозавиток). При необходимости хрящ истончают или слегка надсекают, чтобы сделать его мягче.
4. **Приближение уха к голове:** Если глубокая чаша ушной раковины (раковина) большая, её уменьшают или фиксируют швами к тканям за ухом. Если мочка уха также оттопырена, её корректируют.
5. **Ушивание и повязка:** Кожу закрывают швами. На голову накладывают мягкую, слегка давящую повязку, чтобы сохранить новую форму ушей и не допустить скопления крови.

АНЕСТЕЗИЯ	ПРИМЕРНАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ	ПРЕБЫВАНИЕ В БОЛЬНИЦЕ / ВЫПИСКА
Детям — общая анестезия; взрослым — местная анестезия ± седация или общая анестезия	Около 1–2 часов (обе стороны)	Обычно выписка в тот же день

3 Ожидаемая польза и вероятность успеха

- Уши располагаются ближе к голове и выглядят естественно
- Более симметричный вид обоих ушей
- Меньше социальной тревожности и насмешек, связанных с внешностью; рост уверенности в себе

Большинство пациентов и их семей довольны результатом. Поскольку ушной хрящ — эластичная ткань, по данным публикаций, примерно у **5–10 из 100** пациентов ухо может частично снова отойти вперёд и может потребоваться коррекция. Различия в несколько миллиметров между двумя ушами считаются нормой.

4 Другие варианты лечения

- **Отказ от операции:** Оттопыренные уши не вызывают проблем со здоровьем, поэтому операция не является обязательной.
- **Формирование с помощью шин (молдинг) в период новорождённости:** В первые несколько недель после рождения ушной хрящ очень мягкий, и ему можно придать форму с помощью специальных корректоров; после этого периода метод неэффективен.
- **Маскировка причёской:** Причёски, закрывающие уши, могут скрыть их вид.
- **Безразрезовые / нитевые методики:** У отдельных пациентов с мягким хрящом коррекцию можно провести через крошечные разрезы; частота рецидивов может быть выше, чем при стандартной операции.

5 Что будет, если процедуру не проводить?

Если операцию не проводить, форма ушей останется прежней; со временем сама по себе она не исправится. Оттопыренные уши не представляют опасности для здоровья; решение об операции полностью зависит от внешнего вида и от желания человека (в случае детей — ребёнка и семьи).

Вы имеете право отказаться от рекомендованной процедуры, отложить её или получить мнение другого врача. Это решение никак не повлияет на любую другую медицинскую помощь, которая вам предоставляется. Вы можете отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры; однако, пожалуйста, имейте в виду, что после начала процедуры могут быть этапы, на которых её прекращение небезопасно с медицинской точки зрения.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

6 Подготовка к процедуре

- Перед операцией проводятся необходимые анализы крови; если планируется общая анестезия, вас/вашего ребёнка осмотрит врач-анестезиолог.
- Если применяется общая анестезия или седация, в течение **6–8 часов** до операции нельзя ничего есть и пить (для маленьких детей — в течение времени, указанного анестезиологом).
- Утром в день операции вымойте волосы шампунем. Длинные волосы можно собрать так, чтобы они не попадали в область операции.
- Операция может быть отложена, если вокруг уха есть активная кожная инфекция, экзема или незажившая рана от пирсинга.
- Сообщите врачу обо **всех лекарствах**, которые вы принимаете (включая препараты, разжижающие кровь, аспирин, обезболивающие, средства для похудения и гормональные препараты), а также о любых **растительных средствах и добавках** (например, омега-3, витамин Е, гинкго, чеснок, женьшень, рыбий жир). Не прекращайте приём какого-либо лекарства самостоятельно, без согласования с врачом.
- Обязательно сообщите нам об **аллергиях**, проблемах с кровотечением или свёртываемостью крови, заболеваниях сердца и лёгких, диабете, нарушениях артериального давления или щитовидной железы, перенесённых операциях и любых проблемах, которые возникали у вас при анестезии.
- Если есть вероятность, что вы беременны, или если вы кормите грудью, обязательно сообщите нам об этом до процедуры.
- Курение и никотиносодержащие продукты значительно ухудшают заживление ран. По возможности откажитесь от них как минимум за 2–4 недели до процедуры и не курите в период восстановления.

7 Восстановление: чего ожидать

Первые 48 часов	В ушах могут ощущаться пульсация, стянутость и умеренная боль; их снимают обезболивающими. Рекомендуется спать с приподнятой головой. **Сильная боль с одной стороны, которая продолжает нарастать, — это ненормально**, о ней нужно немедленно сообщить.
2–7-й день	Повязку обычно снимают на контрольном осмотре **со 2-го по 5-й день** и осматривают уши. На этом этапе часто бывают отёк, синяки и болезненность ушей. После снятия повязки носят мягкую **повязку на голову (бандаж для ушей)**. Дети обычно могут вернуться в школу через неделю.
1–2-я недели	Бандаж носят **днём и ночью в течение первых 1–2 недель**, затем **только ночью в течение 4–6 недель**. Это не даёт уху загибаться вперёд во сне и защищает швы. Нерассасывающиеся кожные швы, если они использовались, снимают на 7–10-й день.
3–6-я недели	Бóльшая часть отёка спадает. Контактных видов спорта, плавания и шлемов, давящих на уши, следует избегать как минимум **4–6 недель**.
3–6-й месяцы	Складки ушей устанавливаются, рубец бледнеет, и становится виден окончательный результат. Лёгкое онемение ушей в этот период обычно проходит.

8 Возможные риски и осложнения

Как и любая медицинская процедура, эта процедура сопряжена с определёнными рисками. Ниже **ожидаемые временные эффекты** и **осложнения** приведены отдельно и сгруппированы по частоте их возникновения. Приведённые цифры — **приблизительные** значения, основанные на данных медицинской литературы; ваш личный риск может быть ниже или выше в зависимости от возраста, общего состояния здоровья, курения и перенесённых операций.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Подавляющее большинство осложнений **временные** и проходят при надлежащем лечении. В список включены и очень редкие, но серьёзные события; то, что они упомянуты, не означает, что они произойдут с вами, однако вам необходимо знать о них, чтобы принять осознанное решение.

Ожидаемые временные эффекты (не являются осложнениями — это естественная часть заживления)

- Боль, пульсация и чувство стянутости в первые дни
- Отёк и синяки ушей (1–2 недели)
- Временное онемение кожи ушей и чувствительность к холоду (от нескольких недель до месяцев)
- Тонкий рубец за ухом, который со временем бледнеет

Частые состояния (большинство из них временные или проходят при лечении)

- **Швы, которые прощупываются или выходят через кожу** — Примерно у **5–10 из 100** пациентов постоянные швы, формирующие хрящ, спустя месяцы или годы могут прощупываться за ухом, выходить через кожу или образовывать небольшое воспалённое уплотнение (гранулёму). Обычно это исправляют с помощью простой процедуры по удалению шва.
- **Частичный рецидив (ухо снова отходит вперёд)** — Примерно у **5–10 из 100** пациентов ухо может частично вернуться к исходному положению; при необходимости может быть проведена коррекция.
- **Лёгкая асимметрия** — Два уха никогда не бывают совершенно одинаковыми; различия в несколько миллиметров после операции — норма. Если разница заметна, её можно исправить.

Нечастые состояния

- **Скопление крови в ухе (гематома)** — Встречается примерно у **1–3 из 100** пациентов, обычно в первые 48 часов. Важнейший её признак — **сильная боль с одной стороны, которая продолжает нарастать**. Гематому необходимо **срочно дренировать**, прежде чем нарушится кровоснабжение хряща; при задержке лечения может развиться повреждение хряща и стойкая деформация («ухо борца», «ухо в виде цветной капусты»).
- **Раневая инфекция** — Встречается примерно у **1–5 из 100** пациентов; обычно проходит при лечении антибиотиками.
- **Грубый рубец или келоид** — Примерно у **1–3 из 100** пациентов, особенно с более тёмной кожей или склонностью к келоидам, за ухом может образоваться грубый выпуклый рубец. Может потребоваться лечение инъекциями кортикостероидов, силиконовым гелем или хирургическим путём, и рубец может образоваться снова. Пожалуйста, сообщите нам, если у вас раньше образовывались келоиды.
- **Гиперкоррекция или неестественный вид** — Уши могут выглядеть слишком плотно прижатыми к голове, складка может быть слишком резкой, или средняя часть уха может располагаться дальше назад, чем верхняя и нижняя (вид «телефонной трубки»); при необходимости может быть проведена корригирующая операция.

Редкие или очень редкие, но потенциально серьёзные состояния

- **Воспаление надхрящницы (перихондрит)** — Встречается **менее чем у 1 из 100** пациентов. Проявляется нарастающим покраснением, отёком, ощущением жара и сильной болью в ухе. Может потребоваться внутривенное введение антибиотиков и при необходимости хирургическая обработка; при задержке лечения возможны потеря хряща и **стойкая деформация**.
- **Нарушение кровоснабжения кожи или хряща (некроз)** — Встречается очень редко; обычно связано со слишком тугой повязкой, нелеченой гематомой или инфекцией. Может потребоваться уход за раной, а иногда и восстановительная операция.
- **Стойкое снижение чувствительности или хроническая боль** — Онемение кожи уха или боль в холодную погоду в редких случаях могут оставаться навсегда.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Сужение наружного слухового прохода** — Очень редко после уменьшения или фиксации раковины вход в слуховой проход может сузиться; может потребоваться коррекция.

Общие риски, относящиеся к любому хирургическому / медицинскому вмешательству

- **Риски анестезии:** Если применяется общая анестезия или седация, её риски (тошнота, боль в горле, повреждение зубов, аллергическая реакция и, очень редко, проблемы с сердцем или лёгкими) отдельно разъяснит врач-анестезиолог, и ваше согласие будет получено на **отдельной форме согласия на анестезию**.
- **Кровотечение и переливание крови:** Необходимость переливания крови при этих процедурах возникает очень редко. При серьёзном кровотечении может потребоваться введение крови или препаратов крови; это также связано с собственными очень редкими рисками (например, аллергией или инфекцией).
- **Инфекция:** Раневую инфекцию после операции обычно лечат антибиотиками; в редких случаях может потребоваться дренирование (удаление гноя).
- **Тромбы в венах ног (ТГВ) и в лёгких (тромбоэмболия лёгочной артерии):** При непродолжительных операциях на голове и шее встречаются очень редко. Ранняя двигательная активность снижает риск. Приём гормональных препаратов, курение, ожирение и тромбозы в прошлом повышают риск.
- **Лекарственная аллергия:** Может развиться аллергическая реакция на используемые лекарства, антисептики, пластыри или шовный материал.
- **Рубцы и проблемы с заживлением:** Формирование рубцов у разных людей происходит по-разному; очень редко может образоваться грубый (гипертрофический) рубец или келоид.
- **Риск для жизни:** В наши дни смерть при плановых операциях на голове и шее встречается крайне редко; однако ни одно хирургическое вмешательство не является полностью безрисковым. При серьёзном осложнении может потребоваться лечение в отделении интенсивной терапии и может наступить стойкая инвалидность.

Этот список не охватывает все возможные осложнения; могут возникнуть и другие непредсказуемые и очень редкие события. Если разовьётся осложнение, врач спланирует необходимое лечение и наблюдение; это может потребовать дополнительного лечения, лекарств, процедур или повторной операции.

9 Когда нужно немедленно связаться с нами

- **Сильная боль в ухе с одной стороны, которая продолжает нарастать** (особенно в первые 48 часов) — это может быть признаком скопления крови
- Усиливающееся просачивание крови через повязку или повязка, пропитанная кровью
- **Температура выше 38,5 °C**, нарастающее покраснение, отёк, ощущение жара или выделения из уха с неприятным запахом
- Ощущение, что повязка слишком тугая, или посинение / изменение цвета уха
- Удар по уху или внезапное изменение его формы

Если возникнет что-либо из перечисленного, немедленно позвоните своему врачу: +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Если вы не можете с нами связаться, обратитесь в ближайшее отделение неотложной помощи или позвоните по номеру 112.

10 Рекомендации по лекарствам и повседневной жизни

- Не мочите повязку и не снимайте её самостоятельно до того, как её снимут в клинике. После снятия повязки можно аккуратно принимать душ начиная с того дня, который укажет врач.
- Регулярно носите бандаж в течение указанного вам срока; это важно для стойкого результата.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- В первые недели не лежите на ушах, не загибайте уши вперёд и не надевайте/не снимайте через голову одежду с узким воротом, задевая уши.
- Защищайте уши от солнца и сильного холода как минимум 3 месяца; из-за сниженной чувствительности можно не заметить ожог или обморожение.
- Присматривайте за ребёнком, чтобы он не тянул повязку или бандаж.
- Принимайте назначенные вам лекарства (антибиотики, обезболивающие и т. д.) в рекомендованной дозе и в течение рекомендованного срока. Не принимайте аспирин или подобные ему лекарства, которые могут усиливать кровоточивость, не посоветовавшись с врачом.
- Во время перелётов или поездок продолжительностью более 4 часов после операции пейте много воды, регулярно двигайтесь и, если вам это рекомендовано, носите компрессионные чулки; это снижает риск образования тромбов в ногах.
- В период восстановления рекомендуется не употреблять алкоголь, а также воздерживаться от курения и никотиносодержащих продуктов.
- Пожалуйста, обязательно приходите на все контрольные осмотры. Если вы приехали из-за рубежа, после возвращения домой наблюдение может продолжаться в формате онлайн-консультаций и по фото/видео; если вам понадобится обратиться к местному врачу, вам будут выданы письменный протокол операции и наши рекомендации.

11 Непредвиденные ситуации во время процедуры, образцы тканей и препараты крови

Если во время процедуры возникнет непредвиденная ситуация, врач останется в рамках той процедуры, на которую вы дали согласие в этой форме. **Если нет угрозы для жизни или риска серьёзного вреда для органа**, никакое дополнительное вмешательство, на которое вы не давали согласия, выполняться не будет; в таком случае процедура будет завершена в безопасный момент, а затем вас проинформируют, чтобы решение было принято вместе с вами. Если же ваша жизнь в опасности, будет оказана неотложная помощь, необходимая для сохранения вашей жизни или органа.

Удалённые во время процедуры ткани при необходимости направляются на **патоморфологическое (гистологическое) исследование** для уточнения диагноза. В зависимости от результата может потребоваться дополнительное лечение или наблюдение.

Переливание крови при этих процедурах требуется очень редко и проводится только по жизненным показаниям. Если вы не согласны на введение крови или препаратов крови (например, по религиозным убеждениям), обязательно сообщите об этом до процедуры; возможные последствия такого решения будут отдельно обсуждены с вами и записаны в разделе «Информация, касающаяся лично вас».

12 Фотографии, видеозаписи и ваши персональные данные

До и после процедуры могут быть сделаны **фотографии/видеозаписи** для планирования, наблюдения и оценки результата. Эти материалы являются частью вашей медицинской документации и хранятся конфиденциально. Ваши изображения **ни при каких обстоятельствах не будут использоваться для рекламы, продвижения или в социальных сетях.**

Использование ваших изображений для любых других целей возможно **только с вашего отдельного и явно выраженного разрешения**. Отказ никак не повлияет на ваше лечение, и вы можете отозвать своё разрешение в любое время:

☐ Я согласен(-на) на использование моих изображений **только для медицинской документации и наблюдения за лечением**.

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, чтобы меня нельзя было узнать** (с закрытой областью лица/глаз).

☐ Я разрешаю использовать мои изображения для научных публикаций и обучения врачей **таким образом, что меня можно будет узнать**.

☐ Я **не разрешаю** использование в научных/образовательных целях.

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Ваши персональные данные и данные о здоровье обрабатываются в соответствии с турецким Законом о защите персональных данных № 6698 (KVKK) и соответствующим законодательством в сфере здравоохранения в целях диагностики, лечения и исполнения требований закона лицами, связанными обязательством сохранения профессиональной тайны. Подробную информацию вы найдёте в нашем Уведомлении о защите персональных данных.

13 Информация и примечания, касающиеся лично вас (заполняет врач)

Дополнительные риски, касающиеся данного пациента (сопутствующие заболевания, принимаемые лекарства, перенесённые операции), подробности плана, ожидания пациента, заданные вопросы и полученные ответы. Если добавить нечего, пишется «нет».

14 Заявление пациента

- ☐ Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму на своём языке. Мне было предоставлено достаточно времени для размышления; у меня была возможность задать вопросы, и я получил(-а) удовлетворившие меня ответы.
- ☐ Мне устно и письменно разъяснили моё состояние, цель рекомендованной процедуры, как, кем и где она будет выполнена, её примерную продолжительность, ожидаемую пользу, вероятность успеха, альтернативы и то, что может произойти, если её не проводить.
- ☐ Мне разъяснили частые и потенциально серьёзные риски, а также возможные последствия этих осложнений (в том числе то, что может потребоваться дополнительное лечение или повторная процедура/операция). Я понимаю, что результат любой медицинской процедуры **не может быть гарантирован на 100%**.
- ☐ Я предоставил(-а) точную и полную информацию о своём здоровье, принимаемых лекарствах, аллергиях и перенесённых заболеваниях. Я понимаю, что неполная или неверная информация может увеличить риски.
- ☐ Я понимаю, что соблюдение указаний, данных до и после процедуры, влияет на результат и что посещение контрольных осмотров важно.
- ☐ Я знаю, что могу отозвать своё согласие в любое время до начала процедуры. Я понимаю, что подписание этой формы не освобождает врача от обязанности проявлять должную заботу и тщательность.
- ☐ Я принимаю это решение по собственной воле, без давления с чьей-либо стороны.
- ☐ Я понимаю, что ношение бандажа в течение рекомендованного срока после операции влияет на результат и что несоблюдение этих указаний может повысить риск рецидива.
- ☐ Я понимаю, что эта процедура носит **эстетический характер**, не является медицински необходимой и что у меня всегда есть возможность от неё отказаться. Я обсудил(-а) свои ожидания с врачом, и мне разъяснили реалистичный результат, которого можно достичь.
- ☐ Я понимаю, что идеальная симметрия или точное повторение внешности с фотографии не могут быть гарантированы, что окончательный результат зависит от того, как заживают мои ткани, и что в некоторых случаях может потребоваться корректирующая процедура.

- ☐ **Я ДАЮ СВОЁ СОГЛАСИЕ на описанную выше процедуру.**
- ☐ **Я НЕ СОГЛАСЕН(-НА) на описанную выше процедуру. Мне разъяснили возможные последствия отказа.**

Рекомендуется, чтобы пациент написал собственноручно: «Я прочитал(-а) и понял(-а) эту форму и даю своё согласие».

Частная клиника «Op. Dr. Murat Ayata»
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Турция
Тел.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 Подписи

	ФАМИЛИЯ, ИМЯ	ПОДПИСЬ	ДАТА / ВРЕМЯ
Пациент			
Законный представитель (родитель / опекун) — степень родства:			
Врач, предоставляющий информацию и выполняющий процедуру			
Переводчик (при необходимости) — язык:			
Свидетель (при необходимости)			

Заявление переводчика: я полностью и точно перевёл(-а) эту форму и устные разъяснения врача пациенту / законному представителю на понятный ему язык.

ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ МЛАДШЕ 18 ЛЕТ ИЛИ С ОГРАНИЧЕННОЙ СПОСОБНОСТЬЮ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ

За пациентов младше 18 лет согласие дают **родитель или законный опекун**. Ребёнка информируют в соответствии с его возрастом и зрелостью и учитывают его мнение. За недееспособных пациентов согласие даёт законный представитель.

☐ Если мы осуществляем родительские права совместно, я заявляю, что второй родитель осведомлён об этой процедуре и согласен с ней.

☐ Я заявляю, что не существует судебного решения или спора относительно опеки / попечительства (если они есть, соответствующий документ был предъявлен врачу).

Ребёнок проинформирован в соответствии с его возрастом; мнение ребёнка: _____

Эта форма составлена в двух экземплярах: один хранится в медицинской карте пациента, другой выдаётся пациенту / законному представителю.

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ (ЗАПОЛНЯЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЕ ОТКАЗА)

Я отзываю согласие, которое дал(-а) выше. Мне разъяснили возможные последствия отзыва согласия.

Ф. И. пациента/представителя, отзывающего согласие, подпись, дата и время: _____

Эта форма составлена в соответствии с Положением о правах пациентов Турецкой Республики и принципами информированного согласия Турецкой медицинской ассоциации. Она дополняет, но не заменяет устные разъяснения вашего врача.